

引する過程で出血源となる原因気管支が判明することがある。

末梢肺からの出血に対しては、当該気管支に気管支鏡の先端を楔入し吸引圧をかけて気管支を虚脱させて圧迫止血を試みる。可能であれば出血側を下にした側臥位をとるのが効果的である。出血が収まったら気管支鏡を若干中枢側に引いて出血の状態を観察する。多くは5分程度待つことで凝血塊を形成して止血することが多い。しかし気管支を閉塞する凝血塊を吸引除去すると再出血するのでそのまま吸引せずに触らないこ

とが大切である。

この凝血塊は数日すると自然に咯出されることが多い。出血の際の気管支鏡検査では咳をさせると咯血量が増える可能性があるので可能な限り咳をさせないことが大切である。

文 献

- 1) 田尻守拡ほか：日呼吸ケアリハ会誌 23 : 293, 2013
- 2) 石田順造ほか：気管支学 35 : 392, 2013